

Eficácia e segurança da administração oral e tópica do ácido tranexâmico no tratamento do melasma



O melasma é uma condição cutânea prevalente que afeta principalmente mulheres em idade reprodutiva. Apesar dos diversos tratamentos disponíveis, o controle do melasma é desafiador devido às frequentes recidivas e respostas parciais. O ácido tranexâmico (TXA) tem ganhado destaque como um tratamento potencial devido às suas propriedades antifibrinolíticas e antimelanogênicas. O presente estudo teve como objetivo avaliar a eficácia e segurança do TXA tópico versus oral em pacientes com melasma, a fim de determinar se a administração tópica poderia fornecer uma alternativa viável com melhor tolerabilidade.

MÉTODOS

Ensaio clínico randomizado, unicêntrico, realizado com 50 mulheres. fototipos de pele III ou IV (Fitzpatrick), histórico de melasma superior a 6 meses. Todos os participantes aplicaram protetor solar FPS 60.

N= 50 (idade entre 18-60 anos)

Duração: 12 semanas

TXA-Oral (N=25)	TXA- Tópico (N=25)
Ácido tranexâmico 250 mg 1 caps 2 x ao dia	Ácido tranexâmico 5%, aplicado 2 x ao dia

Avaliação principal: Escala MASI (Melasma Area and Severity Index) no início e após 12 semanas.

Desfechos secundários: segurança e tolerabilidade

RESULTADOS

Redução significativa no escore MASI em ambos os grupos:

- Grupo TXA Oral: Redução de 58,86% (de 6,83 para 4,02; $p=0,001$)

- Grupo TXA Tópico: Redução de 50,88% (de 7,94 para 4,04; $p=0,001$)

Nenhuma diferença significativa entre os dois grupos ao final do estudo ($p=0,97$).

43% dos pacientes tiveram redução superior a 50% no escore MASI.

Efeitos adversos:

- Grupo Tópico: 1 paciente desistiu devido a sensibilidade (eritema e prurido).

- Grupo Oral: 4 pacientes (16%) relataram oligomenorreia (alteração no ciclo menstrual), mas completaram o estudo.

- Nenhum outro efeito colateral grave foi relatado

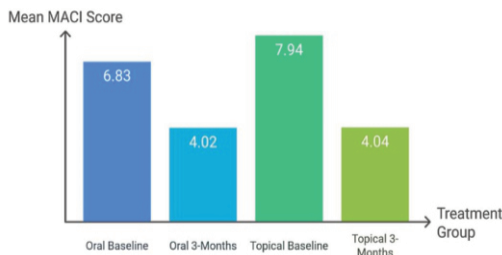


Gráfico 1. Alterações médias na pontuação MACI em cada grupo no início do estudo e após 3 meses de tratamento. Valor de $p \leq 0,05$ é estatisticamente significativo; TXA, ácido tranexâmico.

CONCLUSÃO

Ambas as formas de TXA são eficazes e seguras para o tratamento do melasma. Não houve diferença estatística entre as vias de administração. A escolha entre oral e tópico pode ser baseada na preferência do paciente, conveniência e perfil de efeitos adversos.

HEIDARY, Behrooz; HABIBZADEH MEIBODI, Golnaz Alsadat; ARDAKANI, Mohammad Ebrahimzadeh; RAMEZANI, Vahid; HEIDARI, Fateme. Randomized clinical trial on the efficacy of oral tranexamic acid versus topical tranexamic acid in treatment of melasma. *Journal of Cosmetic Dermatology*, v. 24, e70428, 2025

FORMULAÇÕES

TXA- Oral

Ácido tranexâmico	250 mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Tomar 1 cápsula 2 x ao dia ou conforme orientação médica

TXA- Tópico

Ácido tranexâmico	5%
Apus Lumiwhite [®] qsp	30 g

Aplicar na área afetada da face 2 x ao dia ou conforme orientação médica.

4-hexylresorcinol + Niacinamida

Eficácia na hiperpigmentação e envelhecimento da pele

Estudo in vitro avaliou o efeito sinérgico do 4-hexylresorcinol (4-HR) e niacinamida no aumento da eficácia anti-melanogênica. Além disso, numa fase in vivo, randomizada, duplo-cega e meia-face, estabeleceu a eficácia e segurança desta associação sinérgica no clareamento da pele e atenuação de sinais do envelhecimento. (SHARIFF, Rezwan et al., 2022). De acordo com os resultados, 4-hexylresorcinol com niacinamida é uma combinação potente que promove uniformidade do tom da pele e benefícios antienvhecimento.

4-hexylresorcinol	0,4%
Niacinamida	3%
Apus Low-water [®] qsp	30g

Aplicar na área afetada da face 2 x ao dia ou conforme orientação médica.

Apus Low-Water[®]: Creme dermatológico com baixo teor de água, especialmente indicado para veicular os derivados do resorcinol e associações. Essa tecnologia garante a segurança e eficácia ao tratamento despigmentante, além de conferir um sensorial agradável à formulação.

SHARIFF, Rezwan et al. Superior even skin tone and anti-ageing benefit of a combination of 4-hexylresorcinol and niacinamide. *International Journal of Cosmetic Science*, v. 44, n. 1, p. 103-117, 2022.



apusnutricosmeticos

Distribuição:
NOVAERA
HOMEOPATIA • MANIPULAÇÃO